青年医生门诊医患沟通策略探析

■ 文 / 朱江英

门诊工作因其独特的挑战，如患者众多且常伴有情绪焦虑、病种繁杂多变、医患交流时间有限等难点。青年医生在职业生涯的初期，如果没有建立起缜密的沟通逻辑思路，就可能在沟通过程中出现疏漏，可能导致因沟通不充分而引发误解或纠纷，对医患关系造成负面影响。本文深入分析了这些难点，并强调了通过分阶段沟通策略（准备阶段、接诊阶段、结束阶段）来理清沟通思路的重要性。本文旨在助力青年医生在门诊工作中，通过优化沟通逻辑思路，实现医患沟通的高效与顺畅，从而提升医疗服务质量，促进医患关系的和谐发展。

关键词　门诊　医患沟通　青年医生

前　言

门诊，作为医院最前沿的阵地，不仅是医疗服务的起点，更是医院与社会大众紧密相连的桥梁与窗口。从患者踏入门诊的那一刻起，他们便带着对健康的渴望、对疾病的恐惧以及对未知结果的忐忑，期待得到专业的解答与有效的治疗。门诊医生，作为这一过程中的首要接触者，其言行举止、专业态度、沟通技巧乃至情感关怀，都会深深烙印在患者的心中，成为他们评价医院服务质量和整体印象的重要依据。门诊是医疗纠纷发生的重点区域，而医生的沟通方式起到关键性的作用，就诊中患方情绪主要受沟通方式、自身疾病等影响，医方情绪受到患方情绪反馈的影响，可以说医生的沟通方式是医生个人正面情绪的保障[1]。门诊医患沟通因时间紧、期望高、环境开放、患者流动大及内容广泛，要求医生高效高质，兼顾生理心理需求。青年医生因经验不足，技巧不纯熟，易致沟通不足，影响和谐与疗效。本文剖析门诊沟通障碍，提出分阶段沟通策略，优化沟通效果，提升服务与患者满意度。

门诊医患沟通障碍的主要影响因素

患者多 病种杂

在门诊环境中，患者流量大、病种覆盖广泛是普遍存在的现象。要求医生在极短的时间内迅速了解患者的病史、症状及需求，并给出初步的诊断和治疗建议，这无疑对医生的沟通技巧和效率提出了极高的要求。据调查，高达 57% 的医务人员与 56% 的患者群体一致

作者单位 / 广西医科大学
基金项目 / 广西医科大学青年科学基金资助项目；广西医科大学本科教育教学改革项目
项目编号 / GXMUYSF202461；2023Y65

中国知网　https://www.cnki.net

认同，“患者对于医疗知识的匮乏”构成了医患沟通中的主要障碍因素[2]。疾病多样复杂，医生需广博知识与丰富经验以准确判断并沟通。面对挑战，聚焦患者核心困惑：病因、病理及应对。沟通应紧扣这三大问题，确保不偏离主题。

医患双方情绪影响

在门诊医患沟通中，存在患者焦虑与医生着急互动的问题。患者因疾病、未知、担忧等焦虑，影响沟通，易误解医生。医生则因患者多、任务重、资源紧张而情绪着急。世界卫生组织的深入调查揭示了一个引人关注的现象：在患者尝试阐述自身健康问题的初始 18 秒之内，多数医生便倾向于介入并打断其叙述[2]。医生的情绪着急也可能让患者感到被忽视或不被尊重，进而加剧了患者的焦虑情绪，形成恶性循环。

沟通时间有限

分析沟通障碍时，医患双方普遍认为“医生忙没时间”是主要医方因素[2]。在现实医疗工作中，医生往往需要在有限的时间内处理大量患者，这种工作时间带来的压力可能导致医生在与患者沟通时缺乏耐心和细致，从而影响沟通效果和诊疗效果[4]。时间紧迫，深入讨论病情及治疗方案极具挑战。医生需快速诊断并建议，患者盼全面了解。沟通不清易遗漏，增误解风险。

环境影响

在医患沟通中，我们还应该细心识别并有效应对沟通中可能存在的各种噪音干扰，无论是外界环境的物理噪音，还是由生理状况或心理状态引发的内在噪音，都力求将其对沟通质量的影响降至最低，从而营造出一个更加纯净、和谐且高效的沟通环境[5]。

跨文化沟通障碍

医疗服务中常忽视患者的文化习俗与个人背景，导致沟通不畅；同时，双方健康文化价值观的显著差异也易引发误解与冲突[6]。在医学技术不断发展进步的同时，医疗服务也出现了忽视患者的信仰、习俗和心理需求等问题。医生重技术流程，轻问诊交流，致沟通时间不足，互动失衡[5]。

青年医生门诊医患沟通策略

作为青年医生，必须事先理清沟通思路，确保在宝贵的诊疗时间内，能够有条不紊地引导对话，既深入解答患者当前疑虑，又适时推进至下一个关键议题，避免陷入单一问题的冗长讨论中。为保障沟通的全面性和有效性，我们建议将门诊医患沟通分阶段进行，可以分为准备阶段、接诊阶段和结束阶段。

准备阶段

门诊医患沟通的准备阶段是一个细致入微的过程，它对于确保沟通效果至关重要。研究发现，医疗纠纷中门诊投诉占 59.16%，其中 32.73% 来自服务态度差，服务意识滞后，缺乏对患者应有的同情与关怀，以及在解答患者疑问时展现出的不耐烦与不够细致[7]。因此，在心理准备方面，医生需调整情绪，积极耐心同理，专注倾听患者，提供充分支持。保持冷静理智，应对突发情况。

形象准备同样不可忽视。医生作为医疗服务的提供者，其专业形象和仪表直接影响着患者的第一印象和信任感。因此，医生应穿着整洁、得体的职业装，这不仅有助于提升患者的信任度，也有助于增强医生自身的自信心和职业素养。

环境物品准备也是准备阶段的重要一环。医生需要确保诊室环境整洁、舒适、私密，为患者营造一个独立、安心、安静、放松的就诊氛围，避免嘈杂环境影响沟通过程中的信息传递，避免由于其他不相关人员在场导致患者担心个人信息泄露不能如实告知病情。同时，医生还需要提前准备好必要的诊疗工具和患者资料，如

中国知网 https://www.cnki.net

病历、检查报告、治疗方案等，以便在沟通过程中随时查阅和参考。这些准备工作有助于医生更加高效、准确地了解患者的病情和需求。

综上所述，门诊医患沟通的准备阶段是一个全面而细致的过程，它涵盖了心理准备、形象准备和环境物品准备三个方面。

接诊阶段

接诊为信任基石，诊疗规划前提。融合语言与非语言艺术，确保信息精准，情感共鸣。接诊阶段主要分为三大环节：病史采集、体格检查和语言沟通，每个环节都深刻体现了医患间沟通的深度与广度。

第一步：病史采集与倾听技巧。非语言沟通之倾听技巧：病史采集作为接诊的第一步，其核心在于有效地倾听。青年医生易先入为主，缺乏倾听，难以全面把握病症、了解诉求，更无法有效疏导患者情绪[8]。王锦帆教授在GLTC（示善、倾听、交流、合作）医患沟通模式就强调了医生倾听的重要性，医护人员要全神贯注接收患方全面信息，不随意打断患者[9]。医生通过保持眼神接触、适当地点头、身体前倾等非语言信号，向患者传达出专注与关心，鼓励患者开放地分享自己的症状、感受及病史。倾听不仅仅是耳朵在工作，还有眼神交流，用心记录患者所言，是全身心的投入，它能让患者感受到被尊重和理解，从而建立起初步的信任感。

第二步：体格检查与肢体接触。非语言沟通之肢体接触：体格检查是医生通过直接接触患者身体来评估健康状况的重要环节。在查体过程中，医务人员会细致地使用消毒液清洁双手，操作动作温柔而细心，并伴随语言交流或给予患者适当的安抚，以确保检查过程的安全与舒适[10]。在这一过程中，医生的每一个动作都应体现出专业、细致与尊重。例如，轻柔的手法、温暖的触摸、适时的解释与安抚，都能让患者感受到医生对其诉求的理解和重视。肢体接触不仅是医学检查的需要，更是情感交流的重要方式，有助于加深医患之间的情感联结。

第三步：语言沟通环节。语言沟通围绕核心问题：进入语言沟通环节，医生需围绕困扰患者的三大核心问题展开对话。

“我什么病？”医生应以清晰、易懂的语言向患者解释诊断结果，避免使用过多的医学术语，确保患者能够准确理解自己的健康状况。同时，对于不确定的诊断，应坦诚相告，并说明下一步的检查或治疗方案。

“为什么是我得病？”因医学知识的局限，患者方尤为渴望医方能够详尽阐述诊疗的理论依据、治疗步骤以及药物可能产生的各种影响[11]。面对患者的这一疑问，医生应结合患者提供的病史中相关的详细的病史和医生具体的查体情况分析疾病的可能成因、风险因素等，同时强调个体差异和不可预测性，帮助患者从心理上接受现实，减少不必要的自责和焦虑。

“我该怎么办？”社会颂医德、塑职业形象与标准，却未明患者行为规范，致部分患者偏审视医疗而忽视自我反省[5]。针对治疗疑问，医生应详析方案、效果、副作用及注意事项，强调患者自我管理重要性，辅助以医疗手段，促患者改变不良作息，根治疾病，提升依从性，实现标本兼治。

总之，门诊医患沟通中的接诊阶段是一个高度综合的过程，需医学知识与沟通技巧并重，尤其是非语言与语言沟通，据此建立信任，为后续诊疗打基础。

结束阶段

这一阶段不仅是整个咨询过程的总结，也是建立医患信任、确保患者理解并遵循医嘱的关键环节。门诊医患沟通结束阶段包括信息复核和共情两个方面。

无论是“E4（参与、移情、教育、支持）沟通模式”还是“SEGUE（准备、信息收集、信息给予、理解患者、结束）沟通框架”皆提到了医患沟通的末尾需要再次确认患者是否有其他问题以及说明下一步治疗方案。其主要目的是确

中国知网 https://www.cnki.net

保患者准确理解了医生的诊断、治疗方案以及后续注意事项。信息复核这一过程通常包括以下几个步骤。

总结诊疗要点：医生会用简洁明了的语言，对本次就诊的主要诊断、治疗建议和注意事项进行总结。这不仅帮助患者巩固记忆，也确保了信息的准确性。

核对关键信息：医生会与患者一起核对关键信息，如药物的名称、剂量、服用方法、复诊时间等。这种双向确认的过程可以减少误解和差错，提高患者的依从性。

解答疑问：在总结和核对过程中，如果患者有任何疑问或不明确的地方，医生需耐心解答，直到患者完全理解。这种开放的沟通态度有助于建立患者对医生的信任。

共情为医患沟通关键，结束阶段尤显重要。研究显示：医疗环境中，共情为跨文化沟通能力的关键，与整体能力正相关[12]。共情促医患和谐，增医嘱遵从。青年医生易混共情同情，情绪难控。建议共情后置，基于病情解析，方显真正理解，非空洞同情。结束阶段，共情的体现可以包括以下几个方面。

情感支持：医生会用温暖、鼓励的话语表达对患者的关心和支持。例如，对于病情较重的患者，医生可以表达对其病情的理解和同情，并鼓励其积极治疗，保持乐观心态。

倾听与反馈：医生需要认真倾听患者的感受和需求，并给予积极的反馈。这种倾听不仅是对患者情感的尊重，也是了解患者心理状态、评估治疗效果的重要途径。

建立情感连接：通过共情的沟通方式，有助于患者在面对疾病时感到更加安心和有力量，从而更积极地配合治疗。

引导患者自我认知：在共情的过程中，医生还可以引导患者正视自己的病情和情绪反应，帮助其建立正确的疾病认知和自我管理能力。

门诊医患沟通的结束阶段是一个综合性的过程，既包括对诊疗信息的复核和确认，也包括对患者情感的关注和支持。

总结与不足

门诊医患沟通：时紧、期望高、环境多变。需精准传递信息，兼顾患者情绪与心理。分阶段沟通（准备、接诊、治疗建议、结束反馈）确保完整性，提升效率与质量，增强医患信任，优化医疗效果与患者满意度。本研究只针对青年医生初入门诊工作，为避免慌乱打乱沟通节奏而提出的分阶段沟通，旨在帮助青年医生迅速进入工作状态完成基本沟通，并不能解决所有门诊沟通问题。由于门诊科室涉及众多不同学科，每一个学科又有各自的特色所在，本研究在后续将继续致力于细化学科的特色结合医患沟通技巧提出详细具体的沟通策略。■

参考文献

1. 邵建文，谭港锐，王梦婷，等．门诊经验沟通与 GLTC 沟通对门诊医生情绪状态及沟通细节影响的比较研究 [J]. 中国全科医学，2024, 27(16): 1956-61.

2. 刘芳芳，李晶，陈志斌．医患双方对医患沟通认知情况的 Meta 分析 [J]. 中国老年保健医学，2022, 20(1): 13-6.

3. 李蓓英．医患沟通的伦理清障 [D]. 重庆：西南师范大学，2003.

4. 梁慧，姚晓娟．心理归因机制对优化医患沟通策略的影响 [J]. 中国医学人文，2024,10(5): 12-17.

5. 郭春丽，严金海，赵一俏．我国医患沟通障碍分析 [J]. 中国医学伦理学 ,2018,31(7): 845-850.

6. 陶思怡，梁立波，刘伟，等．跨文化视域下医患沟通问题分析与再思考 [J]. 中国医学伦理学，2020, 33(1): 71-74.

7. 柏燕军，乔晏明，韩继红．333 例医疗纠纷的原因探讨及分析 [J]. 中国实验方剂学杂志，2010, 16(18): 233-4.

8. 谢辉，冯磊，杨丽娟，等．关于心内科青年医师沟通能力提升的探讨 [J]. 医学理论与实践，2022, 35(18): 3225-7.

9. 王锦帆，尹梅．医患沟通学习指导与习题集 [M]. 北京：人民卫生出版社，2018.

10. 邵建文，王锦帆．不同医患沟通方式对门诊模拟患者情绪及需要影响的实验研究 [J]. 医学与社会，2022, 35(8): 115-20.

11. 陈孝春，陈先建，赵淑珍，等．医师职业核心素养视阈下的医患沟通障碍分析 [J]. 温州医科大学学报，2021, 51(5): 428-431.

12.Witte K.Effective Communication in Multicultural Health Care Settings[J]. International Journal of Intercultural Relations, 1994, 19(3):459-462.

中国知网 https://www.cnki.net